

Introduction

Les bilans thyroïdiens sont couramment utilisés pour évaluer la fonction thyroïdienne, notamment chez les patients victimes d'accident vasculaire cérébral.

Objectif :

Cette étude avait pour objectif de comparer le profil biologique thyroïdien chez des patients présentant un AVC ischémique (AVCI) ou un AVC hémorragique (AVCH).

Matériels et méthodes :

Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive réalisée au sein de l'unité de biochimie du laboratoire central du CHU de Sétif et a inclus 110 patients hospitalisés en neurologie (CHU de Sétif), ayant bénéficié d'un dosage de la thyroïdostimuline (TSH) et de la thyroxine libre (T4L) par chimiluminescence sur automate Immulite 2000 Xpi (Siemens).

Résultats :

La population comprenait 92 cas d'AVCI et 18 cas d'AVCH, répartis en cinq tranches d'âge allant de 15 ans à ≥75 ans. L'âge moyen était de 62 ans, avec une prédominance masculine 56 % et sex-ratio H/F de 1,29. La moyenne de la TSH était de 2,97 mUI/L et de la T4L de 1,24 ng/ dl.

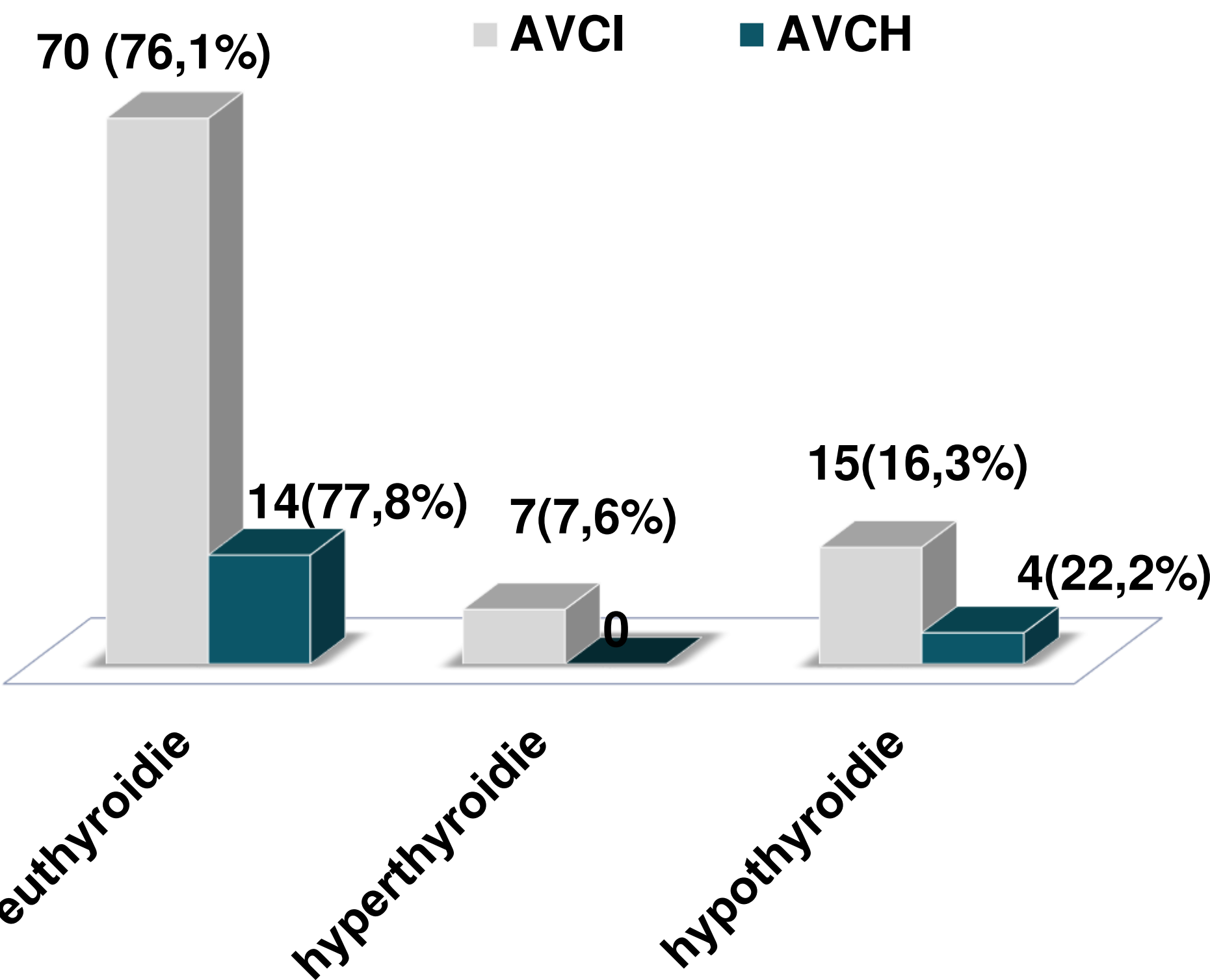


Figure 1 : Répartition des statuts thyroïdiens selon le type d'AVC.

Une variabilité des concentrations moyennes de TSH selon les tranches d'âge, avec des valeurs plus élevées chez les patients de 15–29 ans (4,81 mUI/L) et de ≥75 ans (3,78 mUI/L).

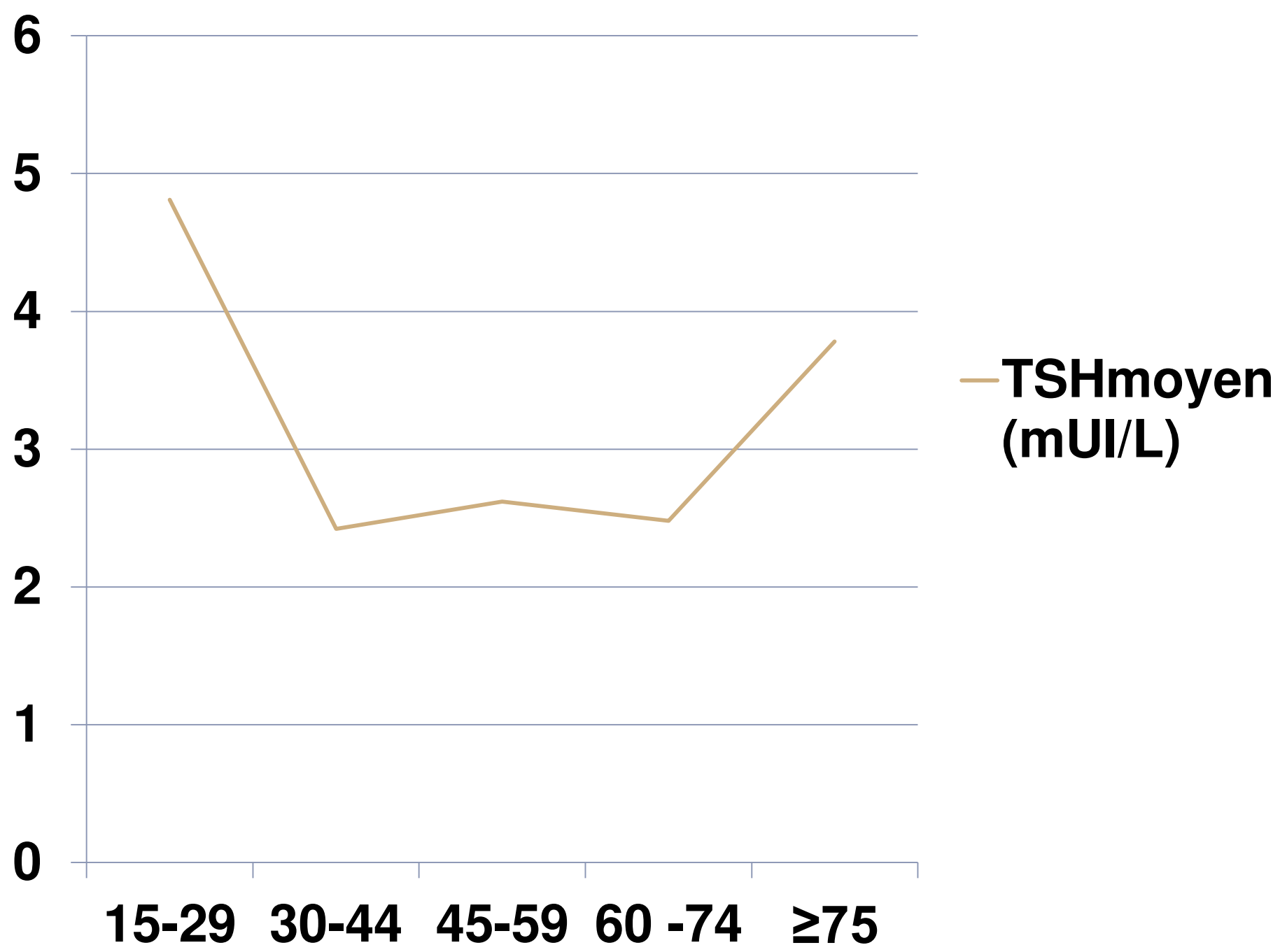


Figure 2 : variation du taux de TSH selon l'âge

L'euthyroidie était le profil majoritaire: 76,1% (39H/31F) pour AVCI et 77,8% (10H/4F) pour les AVCH. Les dysthyroïdies concernent près d'un quart de la population 24 % confirmant leur fréquence importante. Le groupe AVCI présente 7,6% (4H/3F) d'hyperthyroïdie et 16,3% (6H/9F) d'hypothyroïdie. Le groupe AVCH se distingue par absence total d'hyperthyroïdie et une prévalence accrue d'hypothyroïdie 22,2%(3H/1F).

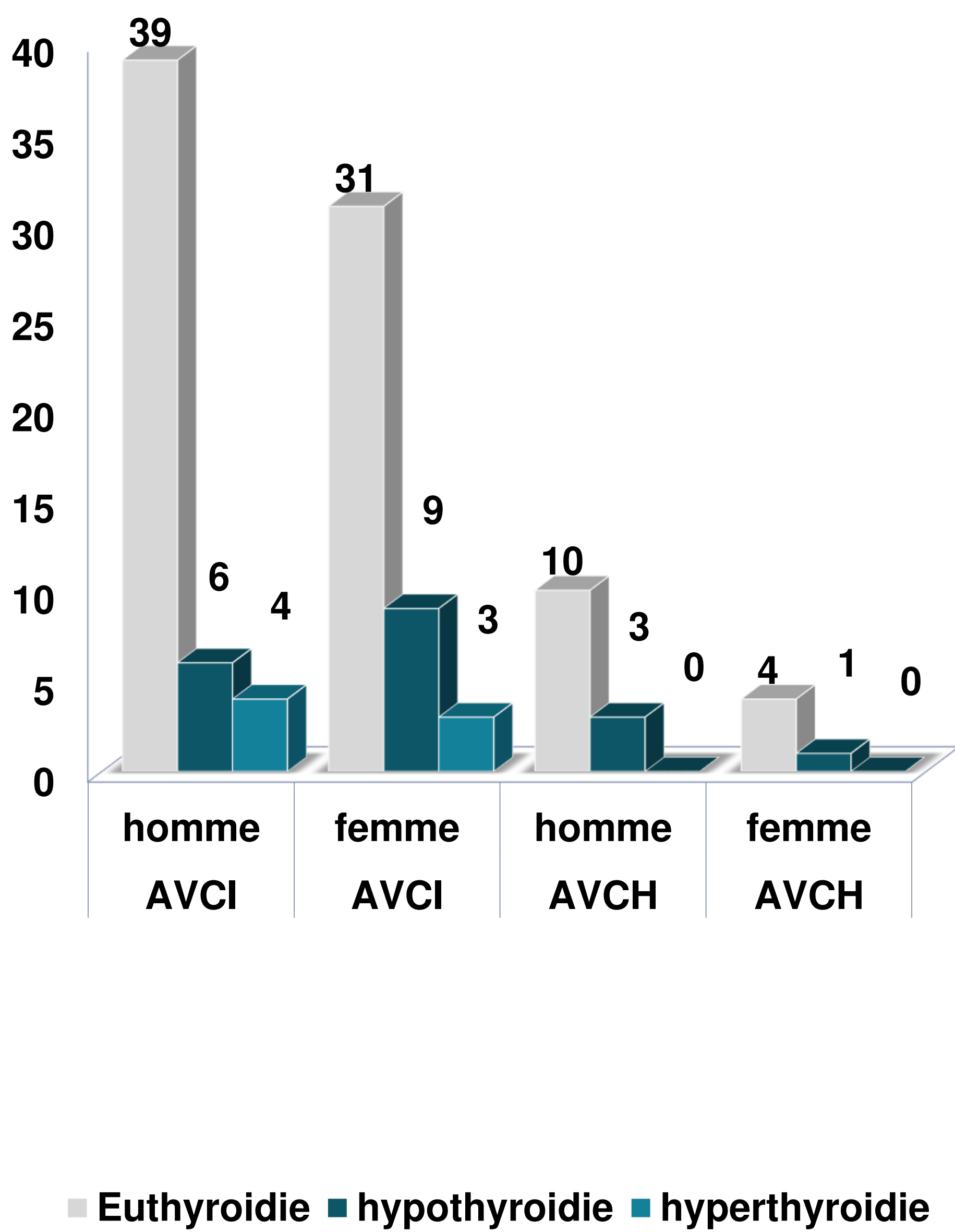


Figure 3 : Répartition des profils thyroïdiens selon le sexe.

Discussion:

La prédominance masculine (56%) observée est probablement liée à la plus forte incidence de l'AVC chez les hommes. L'âge moyen 62 ans est globalement compatible avec le profil épidémiologique habituel des AVC, qui surviennent préférentiellement chez les sujets âgés. L'absence d'association significative entre l'âge et les taux de TSH (p= 0,99), la TSH dépend de nombreux facteurs plus importants que l'âge (stress, l'état nutritionnel et certains médicaments). La répartition des profils biologique montre que l'euthyroidie constituait le profil hormonal majoritaire, aussi bien dans le groupe AVCI (76,1 %) que dans le groupe AVCH (77,8 %). Cette observation suggère que, dans notre population, la majorité des patients ayant présenté un AVC ne présentaient pas de dysfonction thyroïdienne biologique au moment de l'évaluation.

Néanmoins, la prévalence des dysthyroïdies, estimée à 24 % dans l'ensemble de la population étudiée, n'est pas négligeable. La présence de ces anomalies thyroïdiennes pourrait témoigner de l'existence de comorbidités endocrino-métaboliques susceptibles de s'intégrer dans le profil global de risque des patients ayant présenté un AVC. La prédominance de l'hypothyroïdie, suggérant son implication potentielle dans le risque vasculaire via la dyslipidémie, l'athérosclérose et l'hypertension artérielle.

Conclusion

Le bilan thyroïdien constitue un outil biologique essentiel dans l'évaluation des patients victimes d'AVC et s'avère indispensable pour optimiser leur prise en charge.